

KC桌面——外资精译

JPM：GSK核心营业业务与近期数据观察

核心营业利润率目标暗示2030年共识预期存在约1%的上行空间，管线亮点令人鼓舞，但尚需临床数据推动评级上调

昨日，我们参加了GSK的2026年第二季度及"加速增长"活动（参见我们的初步观点）。以下总结我们的主要观点。GSK重申了对>400亿英镑2031年销售目标的信心，该目标现已纳入Nuvalent的贡献，并概述了其重组计划，预计到2029年将实现19亿英镑的年化成本节约，其中大部分预计将重新研究于研发和业务拓展。我们估计，到2029年，这些成本节约可能为核心营业利润带来约2亿英镑的收益，即约60个基点的核心营业利润率提升，但需注意共识预期已计入2026-30年核心营业利润率40个基点的增长，而来自这些成本节约的额外约20个基点的利润率上行空间将为2030年核心营业利润增加约1%的上行空间。在管线方面，关键III期数据读出预计在2028-30年期间，首先是ris-rez（B7H3 ADC）用于广泛期小细胞肺癌、efimosfermin用于F2/F3 MASH以及velzatinib用于2L+胃肠道间质瘤，所有这些药物均面临约2-3年后的激烈竞争。在新产品上市方面，Blenrep超出预期100万英镑，Exdensur低于共识预期200万英镑，两者均保持稳定。总体而言，虽然我们对研发和业务拓展加速的自我融资模式感到鼓舞，但我们预计GSK产品组合需要进一步的临床数据以及上市执行证据，才能推动长期预测的上调，因为共识预期和JPMe仍低于GSK的2031年销售目标（JPMe 2031年：不含Nuvalent为320亿英镑）。

- GSK重申了对>400亿英镑2031年销售目标的信心。GSK重申了对2031年>400亿英镑销售目标的信心，该目标现已纳入近期Nuvalent交易的贡献（参见我们的观点），我们推断这至少抵消了camlipixant在该目标中因近期项目失败造成的损失。>400亿英镑的目标不依赖于未来的业务拓展。GSK还概述了从2031年起加速销售增长的雄心，我们推断这基于当前管线的有机贡献，并辅以业务拓展。
- GSK还宣布了一项重组计划，预计"部分成本节约"将支持集团在多替拉韦专利到期期间的利润率。GSK现在预计在多替拉韦专利到期期间保持利润率持平或改善。虽然这在Nuvalent交易电话会议中已传达，但现已正式确定为2028-30年的目标，其中到2029年实现的19亿英镑年化成本节约的一部分预计将支持这一目标。我们预计成本节约将从2028年开始对损益表产生贡献（JPMe：5000万英镑），全部损益表收益预计在2029年实现，我们估计这可能带来约2亿英镑的损益表收益，或2030年约60个基点的收益。我们认为，公司共识预期已大致反映了这一点，即2026-30年核心营业利润率增长约40个基点，而来自这些成本节约的额外20个基点的潜在利润率上行空间将为共识预期的2030年核心营业利润增加约1%的上行空间。
- 2026财年销售和核心营业利润指引收窄至区间上端，核心每股收益指引收窄至区间下端，增长显著集中在第四季度。GSK强调，由于从第三季度起纳入Nuvalent成本，他们预计核心每股收益增长将显著集中在第四季度，2026年第四季度的增长将受益于2025年第四季度计提的供应链和销售管理费用。
- 关键III期数据读出预计在2028年。GSK强调，他们预计将在2028年提交velzatinib（IDRX-42）用于2L+胃肠道间质瘤、ris-rez（B7H3 ADC）用于2L+广泛期小细胞肺癌以及efimosfermin用于F2/F3 MASH的监管申请。

肿瘤学：公司情况更新

- Blenrep在2026年第二季度实现3600万英镑销售额。GSK指出，Blenrep第二季度3600万英镑的销售额符合其预期，并指出在美国，他们的策略仍是"缓慢推进"，以确保患者获得积极体验。

B7H3 ADC Ris-rez在广泛期小细胞肺癌中的数据。GSK概述了此前公布的ris-rez在广泛期小细胞肺癌中的2L+ SCLC ARTEMIS-001中国仅数据，这推动了III期EMBOLD SCLC-301试验的启动。在I期ARTEMIS-001试验中，ris-rez显示出60%的客观缓解率，中位无进展生存期6.3个月，中位总生存期14.9个月。相比之下，安进*的Imdella在III期试验中显示40%的客观缓解率和13.6个月的中位总生存期，而化疗组中位总生存期为8.3个月（不确定性比：0.60）。ris-rez的中国仅III期试验最近报告了"具有临床意义"的总生存期获益，但我们预计需要该研究的完整细节（可能在2026年ESMO上公布）来评估与Imdella相比的相对竞争力，以及这些数据是否能在全球环境

中重现。我们还注意到，III期EMBOLD SCLC-301全球试验纳入了先前在试验中接受过Imdelltra治疗的患者，这可能会稀释最终的总生存期结果。默克公司的I-Dxd*（B7H3 ADC）在该适应症中也显示出48%的强劲客观缓解率，中位无进展生存期4.8个月，加速批准的PDUFA日期为2026年10月10日，虽然I-Dxd此前因5级及以上间质性肺病事件被部分临床暂停，但该部分暂停已于2026年1月解除。总体而言，我们认为2L+ ESCLC适应症对ris-rez来说是一个适度的机会，因为我们认为Imdelltra设定的高门槛难以超越，因此我们预计该适应症有50%的概率实现5亿英镑的峰值销售机会。

- 强调了B7H4 ADC在卵巢癌和子宫内膜癌中的数据。GSK强调了今年早些时候公布的B7H4 ADC Mo-Rez在2L+子宫内膜癌和铂耐药卵巢癌中的数据（参见我们的观点）。虽然我们认为初步数据令人鼓舞，但我们预计FRa ADC将在铂耐药卵巢癌中占据主要份额，我们预计Genmab的III期数据将在2026年第四季度公布，随后是礼来的sofetabart mipitecan在2027年下半年，以及AZN的torvu-sam在2028年，而Mo-Rez的数据可能在2029年公布。我们还预计需要子宫内膜癌中更成熟的数据（GSK n=33，两个剂量组；AZN n=65；Rina-S n=66，两个剂量组）来评估疗效数据相对于竞争对手的强度，因为2.8mg/kg剂量组显示9%的客观缓解率，而4.8mg/kg剂量组为67%的客观缓解率，我们还注意到GSK的B7H4 ADC的3级及以上治疗相关不良事件发生率为63%，而AZN的puxi-sam为40%，后者在2L+子宫内膜癌中的III期数据读出预计在2027年下半年。
- Nuvalent 更新。GSK 仍预计在 Jideytro (zidesamtinib) 于上周获批用于 $\text{L} + \text{ROS}$ 突变肺癌后，将于2026年下半年为其一线 ROS 适应症提交补充新药申请。ALKAZAR 一线试验招募进展良好，目前入组患者已超过 35%，GSK 指出，在 2026 年 ASCO 上公布 TKI 初治患者的一线数据后，招募兴趣有所增加。我们仍预计 III 期 ALKAZAR 试验将在 2029-30 年读出数据（主要完成日期：2029 年 12 月）。
- ASCO 上公布的 Velzatinib 数据受到关注。GSK 强调了在 ASCO 上公布的 velzatinib 数据（见我们的观点），在二线及以上 GIST 中，velzatinib 在 38 名患者中显示出 38% 的客观缓解率，中位无进展生存期为 13.7 个月，低于 III 期 PEAK 试验中 bezucastinib + sunitinib 报告的 16.5 个月中位无进展生存期，尽管我们注意到 PEAK 试验中对照组的 sunitinib 显示中位无进展生存期为 9.2 个月。基于这些数据，我们认为二线及以上 GIST 试验在 2028 年读出数据有合理的机会，但预计联合疗法的疗效更强，可能比 velzatinib 领先约 2 年，这将导致联合策略占据主要市场份额。GSK 强调，与 bezucastinib + sunitinib 相比，velzatinib 的毒性更低，这是另一个潜在的差异化来源。

HIV：公司情况更新

- VH-499（衣壳抑制剂）联合疗法的 IIb 期 CINERGY 研究，一种每年两次的 HIV 治疗方案，预计将于 2026 年下半年启动。VH184 的 INNOVATE IIb 期试验正在进行中，数据预计于 2027 年公布。GSK 预计将于 2028 年启动 IM VH499 + IM VH184（分别给药）联合疗法的 III 期试验，目标是在 2030 年下半年获批。我们注意到 III 期试验的主要终点可能在 48 周，并且试验招募也需要时间，因此根据 2028 年 III 期试验启动的具体时间，我们预计数据读出可能在 2030 年，但获批可能在 2031 年，这可能导致每 6 个月给药方案在 2031 年的贡献相对有限。
- 卡博特韦（整合酶抑制剂）联合利匹韦林（NNRTI）的 III 期 CUATRO 研究，一种每年三次的 HIV 治疗方案，已于 2026 年 6 月启动，主要终点为第 11 个月的病毒学抑制。GSK 预计将于 2028 年获批，但我们认为这可能更接近 2028 年底，并且取决于招募进度。GSK 仍预计大多数每 2 月一次的 Cabenuva 患者将转为每 4 月一次。
- 每周口服药物开发已启动。GSK 已启动 VH359（一种衣壳抑制剂）的 I 期试验，并在临床前开发中有多个潜在的每周口服整合酶抑制剂和衣壳抑制剂。GSK 预计每周口服药物将在 2031 年占据部分市场。我们注意到竞争对手 GILD 和 MRK 在此领域领先，近期 lenacapavir/islatravir 每周口服药物的 III 期 ISLEND-1 和 2 期阳性数据可能会巩固 Dovato 面临的每周口服竞争，此外还有 BIK/LEN 和 DOR/ISL 在 2027 年可能带来的两药方案竞争，尽管我们预计每周口服药物的潜在影响可能更大。根据我们的调研工作（此处），我们看到医生对每周口服药物的潜力有浓厚兴趣，预计长期将占据 18%

的市场份额。GSK 还概述了其预期，即 HIV 治疗市场在 2031 年将保持稳定，约为 220 亿英镑，与 2025 年持平，仿制多替拉韦/Dovato 口服药物预计将占据少量份额，尽管我们预计仿制 Dovato 的可及性和使用带来的价格不确定性可能会随着时间的推移侵蚀治疗市场的价值。

呼吸、肝病与疫苗

- Exdensur 在 2026 年第二季度的销售额为 1800 万英镑，略低于市场预期。GSK 指出，Exdensur 的 J-code 已于 7 月 1 日生效，GSK 继续建立可及性和覆盖范围，目前超过 50% 的参保患者已获得覆盖。大多数患者起始治疗来自生物制剂初治患者 (56%)，17% 从其他类别转换而来，27% 从 IL-5 转换而来。GSK 预计，鉴于哮喘生物制剂的渗透率为 30%，未来新患者起始治疗中生物制剂初治患者仍将占多数。
- GSK 强调了近期启动的 efimosfermin 在 F4 MASH 和酒精性肝病中的 III 期试验（数据可能在 2030 年公布），补充了在 F2-F3 MASH 中的试验（2028 年读出数据）。在 MASH 领域，针对 F2/F3 患者的 ZENITH-1 和 ZENITH-2 试验正在积极招募，主要完成日期为 2028 年 3 月。GSK 指出，基于约 24 个百分点的安慰剂校正纤维化改善，efimosfermin 在 F2/F3 MASH 中可能具有差异化的疗效特征，而 Novo 的 efruxifermin 改善幅度为 20 个百分点，尽管我们注意到在纤维化改善至少 1 期且 MASH 消退的复合主要终点（即将进行的 III 期试验的主要终点）上，efimosfermin 显示出 21% 的安慰剂校正获益，而 efruxifermin 显示出 36% 的安慰剂校正获益。Novo 的 efruxifermin 在 F2/F3 MASH 中的 III 期 HISTOLOGY 数据预计将于 2026 年底公布。我们已在模型中给予 efimosfermin 50% 的成功概率，对应 20 亿英镑的峰值销售机会，这假设其在 FGF21 类别中占据 30% 的份额。GSK 最近还启动了 F4 MASH 的 NEBULA-1 和 NEBULA-2 III 期试验，上周已入组首例患者。此外，efimosfermin 的开发项目已扩展至 ALD，其 III 期 ALLSTAR 试验预计将于 2026 年下半年启动。GSK 重申了 efimosfermin 在治疗 MASH 方面的同类最佳特征，强调了显示 FGF21 类药剂在推动纤维化改善方面优于非 FGF21 疗法的数据。
- GSK 还强调了其呼吸产品组合的 III 期试验启动，包括其超长效 TSLP（每年两次给药）和每季度一次的 IL-33。GSK 强调了即将在 2026 年下半年启动的长效 TSLP 在慢阻肺和鼻息肉中的 III 期试验，以及长效 IL-33 在 2027 年上半年启动的 III 期试验，我们预计长效 TSLP 的数据读出可能在 2029/30 年，IL-33 的数据可能随后在 2030/31 年读出。我们注意到，在嗜酸性粒细胞性慢阻肺中，TSLP (>150 个细胞/ μm^2) 和 Exdensur (>300 个细胞/ μm^2) 之间存在显著重叠，我们已在模型中为 Exdensur 在哮喘和慢阻肺中设定了约 40 亿英镑的峰值销售额，我们预计这部分销售额将在很大程度上被长效 TSLP 蚕食，具体取决于数据的强度，而 II 期数据尚未公布。